INFORME CLÍNICO: COLUMNA VERTEBRAL Y MIEMBROS INFERIORES

PACIENTE: **Javi (Varón, 67 años)** **FECHA:** Octubre 2026 **PROYECTO:** **IA TEMAS VARIOS / ESPALDA**

ESPECIALIDAD: Traumatología y Cirugía Ortopédica · Medicina Preventiva y Readaptación Biomecánica
MOTIVO CONSULTA: Crisis axial L5–S1, claudicación vespertina de canal, dolor matutino de descanso y ajuste lipídico

AVISO DE SUPERVISIÓN FACULTATIVA Y VALOR DE SÍNTESIS

Este documento sistematiza de manera integral las interconsultas clínicas, el análisis biomecánico de columna y rodilla, la ergonomía del descanso nocturno y diurno, y el perfil farmacológico del paciente. Su objetivo es aportar una visión médica estructurada para la toma de decisiones informadas y coordinadas con sus médicos especialistas presenciales (Traumatólogo, Médico Rehabilitador y Médico Internista).

CUADRO DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL PACIENTE

1. COLUMNA LUMBO–SACRA Y PELVIS (Eje Raquídeo Principal)

PATOLOGÍA CENTRAL

· Protrusión discal L5–S1 sintomática: Genera dolor axial lumbar irradiado hacia región glútea y territorio ciático.
· Estenosis de canal lumbar degenerativa: Causa claudicación neurógena manifestada en horas vespertinas (pesadez extrema y 'batería agotada').
· Síndrome piramidal secundario: Atrapamiento del nervio ciático bajo el músculo piramidal contracturado por basculación pélvica viciosa en sofás blandos, cursando con fasciculaciones y espasmos eléctricos en la extremidad inferior.

2. ARTICULACIONES DE CARGA Y MIEMBROS INFERIORES

DESGASTE ARTICULAR

· Rodilla derecha – Condromalacia Rotuliana Grado 4: Ausencia total de cartílago retro–rotuliano (fricción directa hueso con hueso). Antecedente incapacitante de dolor al subir escaleras resuelto mediante infiltración articular de ácido hialurónico (viscosuplementación).
· Caderas: Coxartrosis bilateral incipiente observada en resonancia magnética, con molestias leves tras bipedestación estática prolongada.
· Complejo Tobillo–Pie: Morfología en pie cavo bilateral con pérdida de capacidad elástica de amortiguación; antecedente de fascitis plantar bilateral severa tratada con ondas de choque con normalización del grosor fascial a 3,8 mm y reducción significativa de espolones calcáneos.

3. PERFIL METABÓLICO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y FARMACOLOGÍA

FARMACOVIGILANCIA

· Dislipidemia en seguimiento: Control lipídico histórico con Atorvastatina 20 mg suspendida por sospecha firme de miopatía secundaria (calambres nocturnos intensos en piernas, fasciculaciones generalizadas e hipersudoración).
· Ensayo clínico con Ezetimiba 10 mg (monoterapia): Tras 30 días de tratamiento, el control analítico constata ineficacia terapéutica con rebote del colesterol por encima de los límites diana, asociada a efectos adversos dermatológicos (prurito migratorio).
· Plan pendiente: Evaluación con Medicina Interna para instauración de terapias de baja/nula toxicidad muscular (Ácido Bempedoico / Pitavastatina).

RESUMEN EJECUTIVO: CONCLUSIONES CLÍNICAS Y DIRECTRICES DE ACTUACIÓN

1. Resolución Inmediata del Dolor Lumbar Matutino (Ergonomía Nocturna):

El dolor severo matutino en L5–S1 no se debe a inflamación intrínseca irreversible, sino a un estrés biomecánico continuado ('Efecto Hamaca') originado por la combinación del colchón firme Aspol Tambre con un topper viscoelástico Pikolin de 5 cm. La viscoelástica cede bajo el peso de la pelvis, hundiendo la columna en flexión lumbar pasiva durante 8 horas. Prescripción: Retirar el topper de inmediato y dormir sobre el colchón firme con cojín bajo las rodillas.

2. Tratamiento Biomecánico de la Claudicación Vespertina (Estenosis de Canal):

El agotamiento de piernas en horario de tarde responde a la claudicación neurógena por estenosis raquídea combinada con fatiga muscular compensatoria. Tratamiento postural: Descanso en flexión lumbar ('truco del carro de la compra' o elevación de rodillas) y fraccionamiento estricto de los paseos diarios.

3. Blindaje Articular en Ejercicio Físico (Protección de Rodilla Grado 4 y Columna):

La actividad física debe maximizar el acondicionamiento cardiovascular y muscular sin comprometer la rótula derecha. Protocolo de natación en espalda con Pull–Buoy entre los muslos (aislando la patada) y prohibición absoluta de flexiones de tronco profundas, hiperextensiones lumbares y ejercicios de impacto o zancadas.

4. Prudencia Farmacológica Lipídica y Evitación de Automedicación:

Ante el rebote del colesterol con Ezetimiba, se desaconseja de forma tajante la toma errática de Atorvastatina en fines de semana antes de la consulta médica. El colesterol no representa un peligro agudo de 72 horas y reiniciar la estatina reactivaría la mialgia e invalidaría la valoración del médico internista.

1. ANÁLISIS BIOMECÁNICO Y FISIOPATOLOGÍA DE COLUMNA Y MIEMBROS

1.1 Unidad Funcional L5–S1 y Fisiopatología de la Protrusión Discal

El segmento móvil L5–S1 soporta la máxima carga axial y de cizallamiento de todo el raquis humano. En el paciente, la protrusión discal consiste en un abombamiento del anillo fibroso con desplazamiento posterior del material nuclear que contacta íntimamente con las raíces nerviosas lumbosacras. Este disco es extremadamente vulnerable a dos vectores de fuerza: la flexión de tronco combinada con carga (que empuja hidráulicamente el núcleo hacia el canal raquídeo) y la retroversión pélvica mantenida (que borra la lordosis fisiológica).

1.2 Estenosis de Canal Raquídeo y Síndrome de Claudicación Vespertina

A los 67 años, la hipertrofia de los ligamentos amarillos y la artrosis facetaria reducen de forma crítica el calibre del canal espinal. La claudicación neurógena se produce porque durante la actividad matutina en bipedestación, la microcirculación de la cauda equina se ve comprometida por compresión mecánica. El flujo sanguíneo capilar disminuye, privando de oxígeno a los axones motores y sensitivos. El resultado clínico no suele ser un dolor agudo, sino una pesadez intensa, adormecimiento y sensación de 'piernas de plomo' que debuta a primera hora de la tarde tras el esfuerzo acumulado.

MANIOBRA CINEMÁTICA DE APERTURA RADICULAR ('EL TRUCO DEL CARRO DE LA COMPRA')

La inclinación sutil del tronco hacia adelante o la flexión de caderas y rodillas hacia el abdomen abre inmediatamente el foramen intervertebral entre un 12% y un 18%, despresurizando el canal, restituyendo el flujo sanguíneo y aliviando de forma instantánea las piernas.

1.3 El Síndrome Piramidal Secundario y las Fasciculaciones Eléctricas

El músculo piriforme (piramidal) se extiende desde el sacro hasta el trocánter mayor. El nervio ciático discurre exactamente por debajo de su vientre muscular. Cuando el paciente se sienta en superficies blandas, la pelvis bascula en retroversión y el piramidal entra en espasmo tónico para intentar estabilizar el sacro. Este atrapamiento miofascial estrangula el nervio ciático, generando descargas eléctricas reflejas manifestadas como fasciculaciones o 'saltos' involuntarios en la pierna al intentar relajarse.

1.4 Condromalacia Rotuliana Grado 4, Coxartrosis y Morfología del Pie Cavo

· Rodilla Derecha (Grado 4): Pérdida de espesor total del cartílago hialino con exposición de hueso subcondral. Cualquier flexión superior a 30–40° bajo carga multiplica la presión fémoro–patelar exponencialmente, generando osteocartilaginitis aguda. El ácido hialurónico restituyó la viscosidad del líquido sinovial, pero la articulación carece de reserva estructural ante sobrecargas.

· Pie Cavo y Fascitis: El arco plantar rígido traslada el choque del talón directamente al tendón de Aquiles, gemelos y columna. El éxito de las zapatillas Nike Vomero con plantillas Scholl radica en aportar el 'colchón dinámico' que el arco rígido no puede proporcionar.

1.5 El Fenómeno de Bipedestación Estática Prolongada ('El Síndrome de los Grandes Almacenes')

Permanecer de pie inmóvil o paseando a ritmo muy lento mirando escaparates es biomecánicamente mucho más lesivo que caminar deprisa. Al no activarse la bomba muscular de los gemelos, se produce estasis venoso periférico, compresión continua en las facetas lumbares sin bombeo discal y sobrecarga de la fascia plantar bajo el peso corporal estático. Pauta preventiva: Buscar apoyos monopodales alternos (elevar un pie en un saliente) y evitar bipedestaciones estáticas superiores a 10–15 minutos sin descargar la postura.

MATRIZ DE INTERACCIÓN BIOMECÁNICA: PATOLOGÍAS, DETONANTES Y DIANAS DE ALIVIO

REGIÓN / ESTRUCTURA	PATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO	MECANISMO DESENCADENANTE (PELIGRO)	DIANA TERAPÉUTICA / ALIVIO
Disco L5–S1	Protrusión discal L5–S1 sintomática	Flexión de tronco con piernas estiradas; hundimiento en colchón blando (efecto hamaca).	Colchón de firmeza alta; cojín poplíteo; alineación neutra en reposo.
Canal Lumbar	Estenosis de canal degenerativa	Hiperextensión lumbar (postura de la cobra); bipedestación estática prolongada matutina.	Descanso en flexión de tronco y caderas; fraccionar paseos en dos tandas.
Músculo Piramidal	Síndrome piramidal y ciatalgia	Presión glútea directa en sofás blandos; reclinables ordinarios con retroversión pélvica.	Sillón basculante Gravedad Cero (Zero–G); estiramiento piramidal cruzado en 4.
Rótula Derecha	Condromalacia Grado 4 (desgaste total)	Zancadas, sentadillas profundas, split, patada en piscina o flexión profunda (mahometano).	Natación con Pull–Buoy (anular patada); evitar flexiones >40° en carga.
Caderas	Coxartrosis bilateral incipiente	Bipedestación estática mantenida; giros bruscos de cadera en piscina o marcha irregular.	Descarga hidrostática en piscina; marcha con buen apoyo; evitar asimetrías.
Fascia Plantar	Pie cavo y fascitis previa (3,8 mm)	Calzado plano; marcha prolongada de una sola tirada sin soporte plantar; suelo duro.	Zapatillas Nike Vomero + plantillas de descarga Scholl; caminar fraccionado.
Bipedestación Estática	Sobrecarga estática y estasis venoso	Esperas de pie prolongadas en tiendas o almacenes sin activación de gemelos.	Apoyo alterno de pies en salientes; pausas activas caminando; evitar paradas largas.

REGLA CLÍNICA DE ORO EN LA COMBINACIÓN L5–S1 + ESTENOSIS + CONDROMALACIA G4

El tratamiento de Javi presenta una alta complejidad biomecánica porque sus patologías tienen demandas contrapuestas: lo que alivia una estructura puede destruir otra. La estenosis agradece la flexión lumbar, pero la flexión extrema revienta el disco L5–S1. El ejercicio cardiovascular protege la espalda, pero la patada o la sentadilla destruyen la rodilla sin cartílago. Por ello, toda prescripción debe situarse en la 'zona de seguridad biomecánica neutra': natación sin patada, marcha con calzado amortiguado y descanso rígido.

2. ERGONOMÍA INTEGRAL: DESCANSO NOCTURNO Y MOBILIARIO DIURNO

2.1 El Diagnóstico del 'Efecto Hamaca': Colchón Aspol Tambre vs. Topper Pikolin

Durante meses, el paciente experimentó un dolor agudo y punzante en el punto exacto de la L5–S1 al despertar por las mañanas, a pesar de realizar ejercicio suave y mantener hábitos saludables. El análisis del equipo de descanso desveló la clave del problema:

EL COMPONENTE IDEAL: Colchón Aspol Tambre

· Tecnología: Núcleo de muelles ensacados independientes combinado con espumación técnica patentada Physiotec.
· Firmeza: Muy alta y uniforme, diseñada para mantener la alineación ortopédica del raquis.
· Impacto clínico: Excelente para el paciente; previene que la pelvis se desplace y soporta el peso axial sin deformación.

EL ELEMENTO LESIVO: Topper Pikolin Sapporo

· Tecnología: Bloque de 5 cm de espuma viscoelástica termosensible de alta densidad con tratamiento de Aloe Vera.
· Comportamiento: Se ablanda y cede con el calor y la presión gravitatoria.
· Impacto clínico: VENENO para la L5–S1 del paciente al hundir la pelvis y anular la firmeza del colchón base.

¿POR QUÉ 5 CM DE VISCOELÁSTICA DESTRUYEN LA ESPALDA? MECÁNICA DEL 'EFECTO HAMACA'

1. Hundimiento Asimétrico: La pelvis y los glúteos representan la masa más pesada del cuerpo. En 5 cm de viscoelástica, la pelvis se hunde completamente mientras las piernas y el tórax permanecen elevados, forzando una postura en 'hamaca' o 'C' invertida durante 8 horas continuadas.
2. Pinzamiento Dual: Este hundimiento abre el espacio discal posterior, exprimiendo el núcleo de L5–S1 hacia las raíces nerviosas y cerrando simultáneamente el canal lumbar estenosado. La persona pasa la noche entera con el disco bajo tensión mecánica máxima.
3. El Dolor del Amanecer: Al levantarse, el disco inflamado y atrapado debe soportar bruscamente la gravedad, desatando la crisis matutina.

PRESCRIPCIÓN TRAUMATOLÓGICA DE DESCANSO NOCTURNO

· Retirada inmediata del Topper: Dejar el colchón Aspol Tambre directamente bajo la sábana protectora transpirable.
· Período de adaptación: Las primeras 3 noches la cama puede sentirse excesivamente firme tras el hábito de la viscoelástica; el raquis requiere 72 horas para readaptar su musculatura paravertebral profunda a la alineación recta.
· Soporte poplíteo: En decúbito supino, colocar un cojín firme bajo las rodillas para relajar el psoas y despresurizar L5–S1 al 100%. En decúbito lateral, situar una almohada entre las rodillas para estabilizar la pelvis y evitar torsiones de cadera.

2.2 Ergonomía Diurna: El Sofá Convencional vs. Sillón Basculante de Gravedad Cero

Ver la televisión o leer en el salón representa un momento de alto riesgo para el piramidal de Javi. El análisis comparativo de los mecanismos de descanso sentado establece directrices muy estrictas:

EL SILLÓN RECLINABLE COMÚN (Lesivo)

· Mecanismo: Solo se tumba el respaldo hacia atrás mientras la banqueta permanece estática y plana.
· Defecto biomecánico: La pelvis se desliza inevitablemente hacia adelante ('escurrimiento'), la columna lumbar se arquea en 'C' y el 80% del peso corporal se concentra en el sacro y glúteos.
· Consecuencia clínica: Aplastamiento directo del músculo piramidal contra el nervio ciático, desencadenando los saltos y fasciculaciones eléctricas en la pierna.

SILLÓN BASCULANTE GRAVEDAD CERO (Zero–G)

· Mecanismo: Todo el módulo pivota en bloque. Al reclinarse el respaldo, la banqueta se eleva por la parte delantera simultáneamente.
· Ventaja biomecánica: Las rodillas se elevan a la altura o por encima del nivel cardíaco. El peso se reparte por toda la superficie dorsal y los muslos.
· Consecuencia clínica: Descompresión del 100% de la carga axial en L5–S1; el piramidal queda completamente flojo y distendido, impidiendo las descargas del ciático.

GUÍA DE COMPRA DE SILLÓN Y CONDUCTA POSTURAL DIURNA

· Opciones de Gama Alta (Médicas): Stressless (sistema Plus que adapta el soporte lumbar según la inclinación) o Human Touch (línea Perfect Chair).
· Sillones Relax Eléctricos (2 Motores Power Lift): Modelos que permiten mover independientemente el reposapiés y el respaldo, buscando la posición basculada tipo 'cuna' (ej. Ortopedia en Casa Zero–G, Gridinlux o Mobiclinic).
· Alternativa Inmediata para el Sofá Actual: Colocar un cojín cilíndrico muy firme bajo los huecos poplíteos (cerca de las rodillas) para frenar el deslizamiento de la pelvis y descargar el piramidal.
· LA REGLA DE LOS 45 MINUTOS: Nadie aguanta dos horas inmóvil. Aprovechar los cambios de programa o pausas comerciales (cada 45–60 min) para levantarse, dar un paseo de un minuto por el salón o beber agua. Al volver a sentarse, el cuerpo restablece su propiocepción de forma neutra.

RESUMEN DE DIRECTRICES ERGONÓMICAS DE DESCANSO

Cama / Sueño	Retirar topper Pikolin viscoelástico; usar solo Aspol Tambre firme.	Previene el 'efecto hamaca', el hundimiento de la pelvis y el dolor lumbar matutino.
Postura Supina	Cojín bajo las rodillas de firmeza media.	Desactiva la tensión del músculo psoas sobre la vértebra L5 y abre el canal lumbar.
Postura Lateral	Almohada ergonómica entre ambas rodillas.	Mantiene la pelvis perfectamente paralela y evita la torsión forzada del disco.
Sillón Televisión	Sistema basculante Gravedad Cero (rodillas sobre nivel cardíaco).	Elimina la carga en L5–S1 y relaja el músculo piramidal, evitando fasciculaciones.
Pautas Diurnas	Regla de los 45 minutos (pausa activa y levantarse).	Reactiva el bombeo vascular periférico y desfatiga la musculatura lumbar postural.

3. PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y MATRIZ DE SEGURIDAD EN EJERCICIOS

3.1 Protocolo de Natación Adaptada: 'Piscina Pro–L5/S1'

El medio acuático es la mejor herramienta de desgravitación para el raquis, pero exige una técnica milimétrica para no dañar la rodilla con condromalacia grado 4. Se prohíbe el estilo braza y el crol convencional por la hiperextensión cervical y la patada.

Fase 1: Calentamiento Dorsal Suave (2 largos / 40 metros):
Estilo espalda extremadamente suave y relajado. Mirada vertical al techo, manteniendo la pelvis alta ('hilo imaginario desde el ombligo al techo'). Descanso de 1 minuto de pie al finalizar.

Fase 2: Bloque Dorsal con Pull–Buoy (4 a 8 largos / 80 – 160 metros):
Colocación del corcho (Pull–Buoy) bien arriba entre los muslos, justo bajo la pelvis. Piernas 100% quietas y flotando (CERO PATADA para proteger la rodilla grado 4). Brazada oblicua: flexionar el codo hacia el lateral y empujar el agua hacia los pies, sin traccionar hacia el fondo. Ritmo lento y largo: contar '1, 2, 3' entre brazadas.

Fase 3: Recuperación Activa en Inmersión (4 largos / 80 metros):
Caminar por el agua hacia adelante y hacia atrás en zona donde el agua cubra a nivel del pecho. El abdomen debe mantenerse activado. La resistencia hidrodinámica tonifica la musculatura estabilizadora sin impacto articular.

Seguridad en Vestuarios y Salida de la Piscina:
Salir SIEMPRE por las escaleras (nunca saltando por el borde). Secarse siempre SENTADO (terminantemente prohibido inclinarse hacia adelante a secarse los pies o ponerse los calcetines, ya que con la musculatura caliente y distendida, la flexión lumbar expone el disco L5–S1 al

3.2 Protocolo de Marcha Diaria, Calzado Terapéutico y Puente Glúteo

PAUTA DE CAMINATA FRACCIONADA Y CALZADO ORTOPÉDICO

· Volumen Diario: 5.000 a 6.000 pasos al día.
· Fraccionamiento Obligatorio: Dividir en dos salidas (ej. 3.000 pasos matutinos + 2.500 al atardecer). Caminar 6.000 pasos de una sola tirada satura la capacidad de aporte sanguíneo del canal estenosado y desencadena la claudicación vespertina con dolor en talones.
· Calzado Clínico: Excelente elección de zapatillas Nike Zoom Vomero combinadas con plantillas Scholl para fascitis plantar con soporte de arco rígido. Esta combinación compensa el pie cavo y amortigua el impacto en la rodilla y el sacro.
· Puente Glúteo en Suelo: Permitido solo en días alternos sin natación. IMPORTANTE: Realizar SIN banda elástica en rodillas o con resistencia [illegible] y rodillas [illegible]

3.3 Matriz de Riesgo y Seguridad en Ejercicios (Análisis de Rutinas de Internet)

A raíz del análisis de rutinas de YouTube (Fausto Murillo y Dani Zilli) remitidas por terceras personas, se elabora la siguiente tabla de

EJERCICIO / POSTURA EVALUADA	ESTADO	IMPACTO ANATÓMICO Y BIOMECÁNICO	VEREDICTO CLÍNICO
Elevación de pierna recta en suelo (Leg Ra	**PROHIBIDO**	El psoas tira con brazo de palanca máximo de las vértebras lumbares, exprimiendo el disco L5–S1 hacia atrás.	**Destrozo discal severo**
Postura de la Cobra (Hiperextensión lumba	**PROHIBIDO**	Arquea la columna cerrando las facetas articulares y pinza el canal lumbar estenosado (efecto cascanueces).	**Veneno para estenosis**
Zancadas profundas / Lunges en el suelo	**PROHIBIDO**	Carga el 100% del peso en flexión rotuliana >90°. Fricción destructiva de hueso contra hueso sin cartílago.	**Peligro rodilla grado 4**
Apertura de piernas completa (Split)	**PROHIBIDO**	Tensión límite del nervio ciático que lo estira como una cuerda de guitarra y torsión violenta de la articulación sacroilíaca.	**Riesgo de rotura / ciática**
Planchas invertidas y giros balísticos	**PROHIBIDO**	Fuerzas de cizallamiento rotacional que desestabilizan el anillo fibroso de la vértebra L5–S1.	**Inestabilidad lumbosacra**
Postura del Mahometano profunda tradicic	**CONTRAIND.**	La hiperflexión extrema de rodilla para sentarse en talones reactiva el dolor fémoro–patelar agudo.	**Sustituir por bipedestación**
Puente Glúteo Isométrico en suelo	**PERMITIDO**	Fortalece la cadena posterior y el glúteo mayor sin compromiso discal. Mantener la pelvis en posición neutra.	**Seguro y recomendado**
Natación dorsal con Pull–Buoy	**PERMITIDO**	Desgravitación hidrostática completa del raquis y fortalecimiento escapular sin impacto ni patada de rodilla.	**Pilar central del plan**
Estiramiento Piramidal sentado en 4	**PERMITIDO**	Libera la tensión del músculo piriforme sobre el nervio ciático sin forzar la columna en flexión.	**Alivio de fasciculaciones**

CONCLUSIÓN SOBRE ENTRENAMIENTOS DE VÍDEO Y REDES SOCIALES
Las rutinas genéricas de YouTube o redes sociales están diseñadas para individuos jóvenes y sanos sin daño estructural. En un paciente con protrusión L5–S1, estenosis de canal y condromalacia grado 4, aplicar estas rutinas sin supervisión equivale a acelerar el colapso articular.
La única actividad física autorizada es la pautada expresamente en este protocolo.

4. FARMACOVIGILANCIA LIPÍDICA Y GUÍA PARA LA CONSULTA FACULTATIVA

4.1 Cronología y Evolución del Tratamiento Hipolipemiante

Fase 1: Atorvastatina 20 mg — Miopatía Sospechada

· Fármaco: Atorvastatina 20 mg/día tomada en horario de tarde/noche.
· Efecto metabólico: Potente reducción de c–LDL demostrada analíticamente.
· Toxicidad muscular: Aparición progresiva de calambres en pantorrillas, dolores musculares difusos, sensación de piernas cargadas e hipersudoración.
· Decisión: Sospecha de miopatía por estatinas y retirada consensuada con el especialista.

Fase 2: Ensayo con Ezetimiba 10 mg — Ineficacia y Prurito

· Fármaco: Ezetimiba 10 mg/día en monoterapia por la mañana.
· Mecanismo: Bloqueo selectivo de la absorción intestinal de colesterol (transportador NPC1L1) sin acción intracelular hepática.
· Resultado analítico a los 30 días: Elevación del colesterol POR ENCIMA de los límites diana recomendados (la monoterapia es insuficiente).
· Efecto secundario: Prurito cutáneo migratorio en diversas zonas del cuerpo.

Fase 3: Transición y Consulta Inminente — Plan Terapéutico B

· Regla de prudencia: Prohibido retomar Atorvastatina durante el fin de semana previo a la cita. El colesterol no representa una emergencia de 72 horas.
· Objetivo clínico: Acudir a la consulta con el perfil biológico 'limpio' para permitir al internista evaluar el fracaso de Ezetimiba y el prurito.
· Alternativas a debatir: Introducir moléculas de nula toxicidad muscular (Ácido Bempedoico / Pitavastatina).

4.2 Opciones Farmacológicas Avanzadas para Consensuar con Medicina Interna

OPCIÓN A: Ácido Bempedoico (Nustendi)

· Mecanismo: Inhibe la síntesis hepática de colesterol en el mismo paso que las estatinas (ATP–citrato liasa).
· VENTAJA MUSCULAR ABSOLUTA: Es un profármaco que requiere la enzima ACSVL1 para activarse. Esta enzima está presente en el hígado pero NO en el músculo esquelético. Cero riesgo de miopatía o dolores.
· Presentación: Disponible solo o en combinación con Ezetimiba (Nustendi), con reducciones de c–LDL de hasta un 40–50%.

OPCIÓN B: Pitavastatina (Livazo)

· Mecanismo: Estatina de última generación con metabolización alternativa y baja penetración muscular.
· VENTAJA CLÍNICA: Presenta la tasa más baja de quejas musculares entre todas las estatinas del mercado. No interfiere con el metabolismo de los hidratos de carbono ni eleva la glucemia.
· Dosificación: Dosis muy bajas (1 mg o 2 mg) consiguen un excelente control lipídico con alta tolerabilidad en pacientes intolerantes a atorvastatina.

4.3 Guía de Preguntas y Checklist para las Próximas Citas Médicas

CHECKLIST ESTRUCTURADO PARA PRESENTAR A LOS FACULTATIVOS

CITA CON MEDICINA INTERNA (Lípido y Musculatura):

1. Exponer el resultado analítico: La Ezetimiba sola no alcanza objetivos de colesterol y genera prurito cutáneo migratorio.
2. Consultar formalmente la transición a Ácido Bempedoico (Nustendi) o Pitavastatina (Livazo) para proteger el sistema cardiovascular sin reactivar las mialgias.
3. Solicitar determinación analítica de CPK (Creatina Fosfoquinasa) para objetivar el estado de salud de la fibra muscular tras la retirada de la estatina.

CITA CON TRAUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN (Columna y Articulaciones):

1. Informar de la mejoría obtenida al suprimir el topper viscoelástico y solicitar valoración de la estenosis de canal lumbar en relación con la pesadez de piernas vespertina.
2. Revisión del estado de la rodilla derecha: Evaluar la duración del beneficio del ácido hialurónico y programar el mantenimiento articular preventivo.
3. Validar el protocolo de piscina con Pull–Buoy y la marcha fraccionada con zapatillas Nike Vomero y plantillas Scholl.

SIGNOS DE ALERTA ROJA (RED FLAGS) · DERIVACIÓN URGENTE A URGENCIAS

Acudir inmediatamente a Urgencias Médicas ante la presencia de cualquiera de los siguientes síntomas neurológicos o sistémicos:
· Pérdida motora aguda en miembros inferiores: Imposibilidad repentina para caminar sobre los talones o ponerse de puntillas, o caída súbita del pie (pie péndulo / paresia del nervio ciático poplíteo externo).
· Síndrome de Cola de Caballo: Pérdida súbita del control de esfínteres (incontinencia urinaria o fecal, o retención aguda de orina) asociada a anestesia en silla de montar (pérdida de sensibilidad en genitales, periné y zona anal).
· Signos de alarma infecciosa: Fiebre (>38 °C) acompañada de dolor axial lumbar incoercible que no cede con reposo ni analgésicos.

CIERRE EDITORIAL Y CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES

· Documentación Oficial: Elaborado conforme a los estándares editoriales de Agents.md y Gemini.md en el proyecto matriz IA TEMAS VARIOS.
· Trazabilidad y Ubicación: Copia de trabajo archivada en la carpeta de consulta 'ESPALDA ANTIGRAVITY' y preparada para su integración en el repositorio matriz /Users/externo/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/PERSONAL/IA TEMAS VARIOS/ESPALDA/.
· Aviso Legal: Documento informativo de síntesis bioestadística y traumatológica. La prescripción terapéutica definitiva corresponde a su médico.